

Dependencia de Benzodiacepinas, Cannabis, Cocaína y Opiáceos

1. Introducción y relevancia clínica

El consumo de sustancias psicoactivas distintas del alcohol ha aumentado sostenidamente en Chile.

Según el **Décimo Estudio Nacional de Drogas (SENDA, 2023)**:

- 14% de los adultos ha usado **cannabis** en el último año.
- 2,4% reporta **uso de cocaína o pasta base**.
- El consumo de **benzodiacepinas sin indicación médica** alcanza 6%.
- Y la **mortalidad por opiáceos** (fentanilo, tramadol, heroína) va en aumento.

Estas sustancias comparten tres características:

1. **Inducen placer o alivio emocional inmediato** (refuerzo positivo).
2. Generan **tolerancia y dependencia** neuroadaptativa.
3. Su suspensión provoca **síndrome de abstinencia** con alta carga clínica y social.

□ En el EUNACOM, suelen aparecer casos de pacientes hospitalizados o ambulatorios que presentan **síntomas de abstinencia, craving o intoxicación aguda**, y se pide el **diagnóstico diferencial y manejo inicial**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Circuito de recompensa cerebral

Todas las drogas adictivas, aunque con mecanismos distintos, **aumentan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens** (vía mesolímbica).

Sustancia	Mecanismo principal
-----------	---------------------

Benzodiacepinas	Potencian GABA-A → inhibición cortical y ansiedad reducida.
Cannabis (THC)	Activa receptores CB1 → modula dopamina y GABA.
Cocaína	Inhibe recaptura de dopamina, noradrenalina y serotonina.
Opiáceos (morfina, heroína)	Agonistas μ -opioides → inhiben GABA → liberación de dopamina.

La **repetida activación dopaminérgica** produce tolerancia y cambios plásticos permanentes en las conexiones del sistema límbico, lo que explica la **craving (ansia de consumo)** y las **recaídas prolongadas**.

2.2. Tolerancia y dependencia

- **Tolerancia:** necesidad de mayores dosis para el mismo efecto.
 - **Dependencia física:** síntomas al suspender la droga.
 - **Dependencia psicológica:** deseo persistente o compulsivo de consumir.
-

2.3. Sensibilización inversa

En drogas estimulantes (cocaína, anfetaminas), la exposición repetida **aumenta la respuesta dopaminérgica al estímulo**, facilitando las recaídas incluso tras años de abstinencia.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A continuación se detallan los cuadros clínicos más relevantes por sustancia.

3.1. Benzodiacepinas (BZD)

Intoxicación aguda

- Somnolencia, incoordinación, disartria.
- Hipotensión, bradipnea, depresión respiratoria (si coingesta con alcohol u opioides).

Abstinencia

- Ansiedad, insomnio, irritabilidad.
- Temblores, sudoración, náuseas.
- Convulsiones y delirium en casos graves.

□ **Riesgo vital:** abstinencia brusca tras uso prolongado → convulsiones.

Diagnóstico diferencial

- Abstinencia de alcohol.
 - Intoxicación por depresores del SNC.
-

3.2. Cannabis

Efectos agudos

- Euforia, relajación, aumento del apetito.
- Alteración de la percepción temporal y memoria.
- Taquicardia, hiperemia conjuntival, boca seca.
- Crisis de ansiedad o pánico en dosis altas.

Uso crónico

- Deterioro cognitivo (atención, memoria).
- Amotivación, apatía, bajo rendimiento.

- Psicosis inducida por cannabis (riesgo ↑ en jóvenes).

Abstinencia

- Irritabilidad, insomnio, disminución del apetito, disforia.
 - Síntomas leves, no potencialmente letales.
-

3.3. Cocaína y pasta base

Intoxicación aguda

- Euforia, hiperactividad, verborrea, taquicardia, hipertensión.
- Midriasis, temblor, diaforesis.
- Paranoia, alucinaciones táctiles (“bichos bajo la piel”).
- Riesgo de arritmias, infarto, ACV, convulsiones.

Abstinencia

- Fatiga intensa, hipersomnia, anhedonia.
- Tristeza, ideación suicida, ansiedad.
- “Craving” muy intenso.

Complicaciones

- **Infarto miocárdico.**
 - **Accidente cerebrovascular.**
 - **Psicosis cocaínica.**
 - **Perforación del tabique nasal (uso crónico).**
-

3.4. Opiáceos (morfina, heroína, metadona, fentanilo)

Intoxicación aguda

- Miosis puntiforme.
- Depresión respiratoria y del sensorio.
- Bradicardia, hipotermia.
- Edema pulmonar no cardiogénico.

□ **Tríada clásica:** miosis + depresión respiratoria + coma.

Abstinencia

- Inicia 8–12 h tras última dosis, pico a 48–72 h.
- Rinorrea, lagrimeo, piloerección (“piel de gallina”).
- Dolores musculares, bostezos, insomnio, vómitos, diarrea.
- No es letal, pero sumamente desagradable.

Complicaciones

- Endocarditis, VIH, hepatitis B/C.
- Abscesos y sepsis por uso IV.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes básicos

- Hemograma, perfil hepático, renal y electrolitos.
 - Glicemia capilar.
 - ECG (cocaína → prolongación QT, arritmias).
 - Orina toxicológica (detección de metabolitos).
-

4.2. Criterios diagnósticos (DSM-5)

Trastorno por uso de sustancia:

≥2 de los siguientes en 12 meses:

1. Consumo en cantidades o tiempo mayores al planificado.
2. Deseo persistente o esfuerzos fallidos por reducir.
3. Mucho tiempo dedicado a conseguir o usar la sustancia.
4. Craving o deseo intenso.
5. Deterioro social, laboral o académico.
6. Abandono de actividades importantes.
7. Uso en situaciones de riesgo.
8. Continuación a pesar de consecuencias.
9. Tolerancia.
10. Abstinencia.

Gravedad:

- Leve: 2–3 criterios.
- Moderado: 4–5.
- Grave: ≥6.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / Chile)

El manejo debe ser **integral y escalonado**, combinando **farmacoterapia, psicoterapia y rehabilitación psicosocial**.

5.1. Benzodiacepinas

a. Desintoxicación

- **Reducción gradual** (10–20% por semana).
- Sustitución por una benzodiacepina de vida media larga (**diazepam o clonazepam**) para evitar convulsiones.
- Hospitalización si abstinencia severa o riesgo suicida.

b. Apoyo farmacológico

- Anticonvulsivantes (valproato, carbamazepina) para estabilizar el ánimo.
 - TCC para ansiedad subyacente.
-

5.2. Cannabis

- No requiere desintoxicación farmacológica específica.
 - Intervención motivacional y **terapia cognitivo-conductual (TCC)**.
 - En psicosis inducida: **antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina)**.
 - Evitar benzodiacepinas por riesgo de dependencia cruzada.
-

5.3. Cocaína

a. Manejo de intoxicación aguda

- **Benzodiacepinas (lorazepam o diazepam)** para agitación e hipertensión.
- **Nitroglicerina o verapamilo** si dolor torácico (NO betabloqueadores).
- En convulsiones → benzodiacepinas IV.
- Monitorización cardíaca y corrección de electrolitos.

b. Abstinencia y craving

- No hay fármaco específico aprobado.
- **TCC** y programas de rehabilitación intensiva.

- Estudios en curso: bupropión, modafinilo, naltrexona (uso experimental).

5.4. Opiáceos

a. Intoxicación aguda

- **Naloxona IV o IM 0,4 mg** (repetir cada 2–3 min hasta recuperación respiratoria).
- Requiere vigilancia por posible “rebote” de depresión respiratoria.
- Monitoreo y soporte ventilatorio.

b. Abstinencia

- **Metadona:** agonista μ de acción larga; reduce craving y síntomas.
- **Buprenorfina/naloxona:** agonista parcial; inicio cuando aparecen síntomas leves (COWS ≥ 8).
- **Clonidina o lofexidina:** alivio de síntomas vegetativos (taquicardia, sudoración).
- Hidratación, nutrición y apoyo psicológico.

c. Rehabilitación a largo plazo

- **Terapia de mantención con metadona o buprenorfina** supervisada por programas MINSAL.
- **Psicoterapia cognitivo-conductual y comunitaria.**
- Prevención de recaídas y apoyo social.

6. Complicaciones y pronóstico

Sustancia	Complicaciones médicas principales	Pronóstico
-----------	------------------------------------	------------

Benzodiacepinas	Caídas, depresión respiratoria, accidentes	Buena con retiro gradual
Cannabis	Psicosis, deterioro cognitivo, amotivación	Variable, depende de edad y frecuencia
Cocaína	Infarto, ACV, arritmias, psicosis	Alto riesgo de recaídas
Opiáceos	Sobredosis, VIH, hepatitis, sepsis	Requiere tratamiento prolongado y supervisión

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Benzodiacepinas:** retirar gradualmente; abstinencia brusca → convulsiones.
2. **Cannabis:** la psicosis inducida puede requerir antipsicóticos atípicos.
3. **Cocaína:** nunca usar **betabloqueadores** en intoxicación aguda.
4. **Opiáceos:** la **naloxona** revierte depresión respiratoria; repetir si reaparece.
5. **Metadona y buprenorfina** son fármacos MINSAL para mantención.
6. **Clonidina** alivia síntomas vegetativos en abstinencia opiácea.
7. **Craving y recaídas** son parte del curso crónico, no del fracaso terapéutico.



Errores comunes

- Suspender benzodiacepinas abruptamente.
 - Usar haloperidol o betabloqueadores en intoxicación por cocaína.
 - Administrar naloxona en sobredosis mixta con benzodiacepinas sin soporte ventilatorio.
 - Minimizar la dependencia al cannabis (“solo es marihuana”).
 - Tratar solo la intoxicación aguda sin derivar a programas de rehabilitación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Todas las drogas adictivas **activan el circuito dopaminérgico mesolímbico**, generando refuerzo y dependencia.
2. La **abstinencia de benzodiacepinas** puede ser letal; requiere reducción gradual o sustitución.
3. El **cannabis** puede inducir psicosis y deterioro cognitivo en uso prolongado.
4. La **cocaína** produce estimulación simpática severa: hipertensión, arritmias, infarto.
5. Los **opiáceos** causan depresión respiratoria; se revierte con **naloxona**.
6. El tratamiento exitoso combina **fármacos + psicoterapia + rehabilitación social**.
7. Las **Guías MINSAL** priorizan la continuidad asistencial a través de **COSAM y programas de tratamiento integral**.